CLASE ESPECIAL

CIRUGÍA ROBÓTICA

DR. BARBA

PLATAFORMAS QUIRÚRGICAS

- Da Vinci (D5): plataforma consolidada globalmente, con consola, carro del paciente y torre de visión.
- Hugo (Medtronic): modular, 4 torres independientes. Monarch (Ethicon): flexible, para endoluminal.
- Óptica 3D-HD, 7 grados de libertad, Endowrist (supera la rotación de la muñeca humana), filtrado del temblor.



CIRUGÍA GINECOLÓGICA Y UROLÓGICA

- Prostatectomía radical robótica: estándar actual en muchos centros, por mejor preservación nerviosa y continencia urinaria postoperatoria.
- Histerectomía robótica: mayor precisión en disección de ligamentos uterinos, útil en casos oncológicos.

HERNIOPLASTIA INGUINAL Y VENTRAL

- Abordaje TAPP preciso: disección fina del cordón espermatico y vasos epigástricos, diferenciando hernias directas de indirectas; menor dolor y alta ambulatoria el mismo día.

CURVA DE APRENDIZAJE

- Requiere entrenamiento estructurado en simuladores antes de casos reales; la curva es más corta que en laparoscopia convencional por la intuitividad de los movimientos.

CIRUGÍA HEPATOBILIAR Y PANCREÁTICA

- En pancreatectomía distal: mayor preservación de vasos esplénicos vs laparoscopía, menos sangrado intraoperatorio y menor estancia hospitalaria.

CIRUGÍA COLORRECTAL Y ESOFÁGICA

- Menor tasa de conversión a cirugía abierta vs laparoscopía, sobre todo en pelvis masculina estrecha.
- Miotomía de Heller: menos perforación mucosa. Gastrectomía por adenocarcinoma: recuperación funcional más rápida.

FACTORES ECONÓMICOS Y FUTURO

- Da Vinci D5: inversión inicial >$2,000,000 USD + mantenimiento + insumos desechables programados. Nuevas plataformas (Hugo, Monarch) reducirán costos; la formación robótica ya es requisito en residencias.

LIMITACIONES ACTUALES

- Ausencia de retroalimentación táctil (háptica); tiempo quirúrgico inicial mayor; curva de aprendizaje institucional, no solo individual.

